التاريخ / / 20م
الموضوع : .....
المشفوعات : .....
الرقم : .....

تجمع القصيم الصحي
Qassim Health Cluster
Empowered by Health Holding co.

مسابقة التميز بجودة خدمات الرعاية الصحية

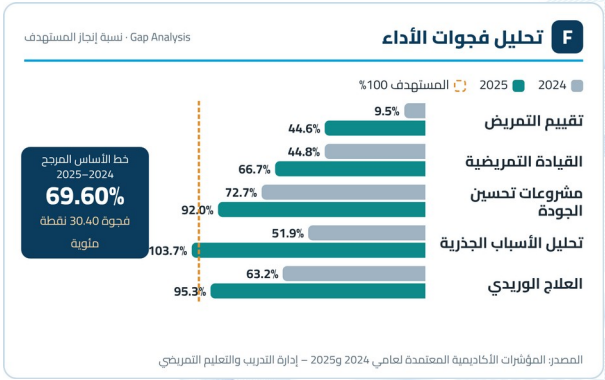
Performance Improvement Project – 2026 مشروعات تحسين الأداء 2026

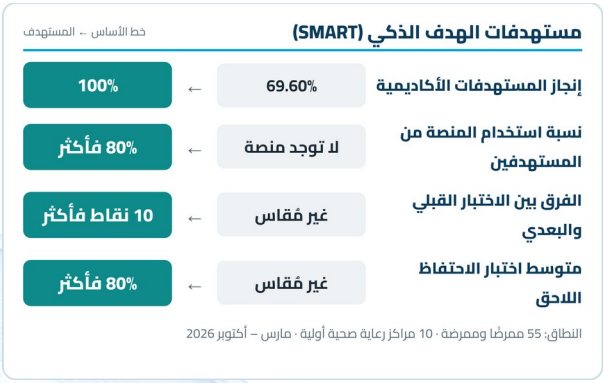
(Only Completed Projects) (فقط المشروعات المكتملة)

الأسبوع العالمي للجودة 2026: «الجودة .. محرك الأداء» – Quality .. Powering Performance

Hospital Name اسم المستشفى / الجهة	Project Title مسمى المشروع	Department Owner (القسم المسؤول)	Department Contributed (الأقسام المشاركة)
قطاع الصحة العامة بالبكيرية تجمع القصيم الصحي	تحسين جودة وكفاءة التدريب التمريضي من خلال التحول الرقمي والتعلّم المدمج بمراكز الرعاية الصحية الأولية	التدريب والتعليم التمريضي	• الدعم التقني: برمجة المنصة الإلكترونية • المراكز الصحية العشرة: التطبيق والورش التطبيقية
Project Dimension(S) (اختصاص المشروع)	**Project Duration** (مدة المشروع)	**Project Start Date** (تاريخ بداية المشروع)	**Project End Date** (تاريخ نهاية المشروع)
☐ Safety (السلامة) – أثر غير مباشر ☑ **Effectiveness (الفاعلية)** ☑ **Efficiency (الكفاءة)** ☑ **Beneficiary Centered** (محورية المستفيد: الكادر كمستفيد داخلي)	**8 أشهر**	**مارس 2026**	**أكتوبر 2026**

Problem Statement (صياغة المشكلة)	Aim Statement: (SMART) (صياغة الهدف الذكي)
خلال عامي 2024–2025 لم تتحقق مستهدفات الخطة التدريبية التمريضية بالكامل في **10 مراكز للرعاية الصحية الأولية**؛ إذ بلغ المتوسط المرجح لإنجاز المؤشرات الأكاديمية المعتمدة **69.60%** مقابل مستهدف **100%** (فجوة **30.40 نقطة مئوية**)، مع تدنٍّ حاد في بعض المجالات (تقييم التمريض 9.5% في 2024). ارتبطت الفجوة بآلية تقديم تعتمد على محاضرات Zoom متزامنة بمواعيد ثابتة لا تتوافق مع المناوبات وتغطية العيادات، ما استلزم **إعادة محاضرات في ربعين مختلفين** وجهدًا تنسيقيًا متكررًا، مع **غياب آلية منهجية لقياس أثر التعلّم**؛ وهو ما ينعكس على جاهزية الكادر التمريضي وجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.	رفع نسبة إنجاز المستهدفات الأكاديمية للتدريب التمريضي في 10 مراكز رعاية صحية أولية **من 69.60% إلى 100%** خلال الفترة **مارس – أكتوبر 2026**، عبر منصة تعلّم مدمج موحدة تتيح 5 محاضرات مسجلة تغطي 12 موضوعًا للفئة المستهدفة (55 ممرضًا وممرضة)، مع تحقيق: • **نسبة استخدام للمنصة ≥ 80%** من المستهدفين. • **تحسّن ≥ 10 نقاط مئوية** بين متوسطي الاختبار القبلي والبعدي. • **متوسط ≥ 80%** في اختبار الاحتفاظ اللاحق بالمعلومات. مع تعزيز التطبيق العملي عبر ورش داخل المراكز الصحية.



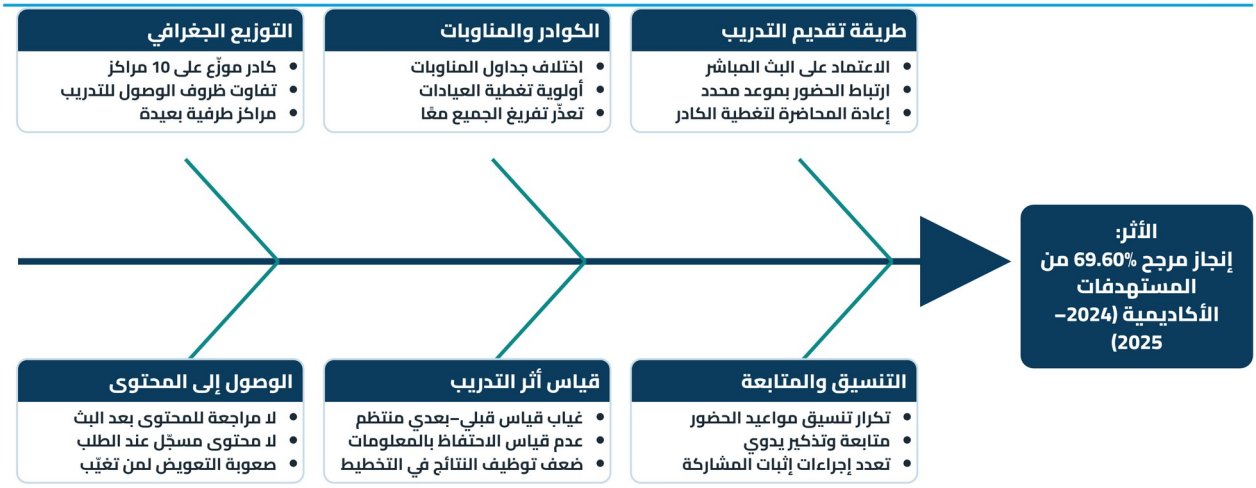


Project Steps (FOCUS – PDCA) خطوات المشروع تبعًا لمنهجية

FOCUS Steps / Description / Tools الخطوات / الشرح / الأدوات	Insert relevant graphs, data, charts الرسوم البيانية والبيانات والمخططات ذات الصلة
F: Find – إيجاد المشكلة **الوصف:** مراجعة المؤشرات الأكاديمية المعتمدة لعامي 2024 و2025 لخمسة مجالات تدريبية في 10 مراكز، ومقارنة المتحقق بالمستهدف. بلغ المتوسط المرجح للإنجاز **69.60%**، وتراوح إنجاز 2024 بين 9.5% و72.7%. ورغم التحسن الجزئي في 2025 بتكثيف محاضرات Zoom وإعادة بعضها، استمر الاعتماد على مواعيد ثابتة. حُدِّد نطاق التحسين بعملية **«تقديم التدريب النظري وقياس أثره»** دون تغيير الموضوعات الأكاديمية المعتمدة. **الأداة:** تحليل فجوات الأداء **(Gap Analysis)** + مراجعة البيانات التاريخية	**F** تحليل فجوات الأداء — Gap Analysis · نسبة إنجاز المستهدف 2024 2025 المستهدف 100% تقييم التمريض 9.5% / 44.6% القيادة التمريضية 44.8% / 66.7% مشروعات تحسين الجودة 72.7% / 92.0% تحليل الأسباب الجذرية 51.9% / 103.7% العلاج الوريدي 63.2% / 95.3% خط الأساس المرجح 2025–2024: 69.60% فجوة 30.40 نقطة مئوية المصدر: المؤشرات الأكاديمية المعتمدة لعامي 2024 و2025 – إدارة التدريب والتعليم التمريضي
O: Organize Team – تشكيل الفريق **الوصف:** مبادرة بقيادة **مشرفة التدريب والتعليم التمريضي** (المساءلة والتنفيذ: تحليل البيانات، تصميم التدخل، إعداد المحتوى والاختبارات، التنسيق مع المراكز، قياس النتائج)، بدعم **مطوّر تقني** لبرمجة المنصة وفق المتطلبات المحددة، وبالتنسيق مع **المراكز الصحية العشرة** لتسهيل التطبيق والورش. وُثّقت الأدوار في مصفوفة RACI لضمان وضوح المساءلة ومنع ازدواج المهام. **الأداة:** مصفوفة المسؤوليات **(RACI Matrix)**	**O** مصفوفة المسؤوليات (RACI Matrix) النشاط / قائدة المشروع / المطوّر التقني / المراكز الصحية تحليل الفجوات وتصميم التدخل — A / R — I — C إعداد المحتوى العلمي والاختبارات — A / R — – — I برمجة المنصة الإلكترونية — A — R — – التجربة والتعميم على المراكز — A / R — C — C الورش التطبيقية وقياس النتائج — A / R — – — C متابعة المؤشرات والاستدامة — A / R — C — I R: منفّذ · A: مساءل/معتمد · C: مُستشار · I: مُبلَّغ
C: Clarity – توضيح العملية المتعلقة بالمشكلة **الوصف:** رُسمت العملية الحالية (As-Is) في 5 خطوات وحُدِّدت **4 نقاط اختناق/هدر**: الموعد الثابت للبث، والتنسيق المتكرر مع 10 مراكز، وتعارض الحضور مع المناوبات، وإعادة المحاضرة لمن تغيّب، مع غياب نقطة لقياس أثر التعلّم. ثم صُمِّمت العملية المستهدفة (To-Be) مسارَ تعلّمٍ مدمج عند الطلب: **دخول المنصة ← اختبار قبلي ← محتوى مسجّل ← اختبار بعدي ← اختبار احتفاظ وورشة تطبيقية.** **الأداة:** مخطط سير العملية قبل/بعد **(Process Flowchart: As-Is / To-Be)**	**C** مخطط سير العملية (Process Flowchart) — قبل التحسين مقابل بعده قبل التحسين – بث مباشر بموعد ثابت إعداد المحاضرة ← تحديد موعد بث ثابت ← تنسيق متكرر مع 10 مراكز ← حضور يتعارض مع المناوبات ← إعادة المحاضرة لمن تغيّب بعد التحسين – مسار تعلّم مدمج عند الطلب الدخول للمنصة في أي وقت ← اختبار قبلي ← محتوى مسجّل عند الطلب ← اختبار بعدي ← اختبار احتفاظ + ورشة تطبيقية نقطة اختناق / هدر خطوة مُحسّنة ألغي الاعتماد على الموعد الثابت والتنسيق المتكرر، وأُضيفت نقاط قياس للتعلم داخل المسار
U: Understand – تحديد الأسباب الجذرية للمشكلة **الوصف:** صُنِّفت الأسباب المحتملة في **6 محاور** (طريقة التقديم، الكوادر والمناوبات، التوزيع الجغرافي، الوصول إلى المحتوى، قياس الأثر، التنسيق والمتابعة)، ثم طُبِّق «لماذا الخمس»: لماذا لم تتحقق المستهدفات؟ لصعوبة حضور الكادر ← لأن الحضور مرتبط بموعد بث ثابت ← لأن التدريب متزامن فقط ← لعدم وجود محتوى مسجّل ومنصة موحدة ← لغياب مسار رقمي متكامل للتعلّم والقياس. **السببان الجذريان:** (1) ارتباط التدريب النظري بموعد متزامن واحد لا يتوافق مع المناوبات، (2) غياب مسار منهجي لقياس التعلّم يوجّه المتابعة. واستُبعد «غياب المؤشرات» لأنها معتمدة ومتاحة. **الأداة:** مخطط عظمة السمكة **(Fishbone / Ishikawa)** + تحليل لماذا الخمس **(Whys 5)**	

U مخطط السبب والأثر – عظمة السمكة (Fishbone / Ishikawa)

تصنيف الأسباب المحتملة لتدني إنجاز المستهدفات التدريبية



الأسباب الجذرية ذات الأولوية (بعد تحليل «لماذا الخمس»): ارتباط التدريب بموعد بث ثابت يتعارض مع المناوبات + غياب مسار قياس متكامل للتعلم. المؤشرات الأكاديمية معتمدة ومتاحة ولم تُصنَّف سببًا.

S: Select – تحديد الحلول للمشكلة مرتبة حسب الأولويات

الوصف: قورنت **3 بدائل** وفق **6 معايير** (مرونة التوقيت، ملاءمة المراكز الطرفية، قياس التحسن المعرفي، التطبيق العملي، الجهد التنظيمي، شمولية معالجة الأسباب). اختير **التعلّم المدمج**: منصة موحدة بمحتوى مسجّل واختبارات قبلية/بعدية/لاحقة + ورش تطبيقية قصيرة داخل المراكز؛ لأنه البديل الوحيد الذي يعالج السببين الجذريين معًا. ويتّسق الاختيار مع الأدلة العلمية؛ إذ أظهرت مراجعة منهجية وتحليل تلوي (Liu et al., 2016) أن التعلّم المدمج في المهن الصحية يحقق نتائج معرفية أفضل من التعليم التقليدي أو مماثلة له.

الأداة: مصفوفة المفاضلة بين الحلول (Solution Selection Matrix)

S مصفوفة المفاضلة بين الحلول — Solution Selection Matrix

معيار المفاضلة	محاضرات مباشرة متكررة	تعلّم إلكتروني فقط	تعلّم مدمج ✔
مرونة التوقيت مع المناوبات	منخفضة	مرتفعة	مرتفعة
ملاءمة المراكز الطرفية	متوسطة	مرتفعة	مرتفعة
قياس التحسن المعرفي	ممكن	ممكن	مدمج بالمسار
التطبيق العملي للمهارات	محدود	غير مباشر	ورش داخل المراكز
الجهد التنظيمي المتكرر	مرتفع	منخفض	منخفض
شمولية معالجة الأسباب	جزئية	جزئية	الأشمل

Project Steps (FOCUS – PDCA) خطوات المشروع تبعًا لمنهجية

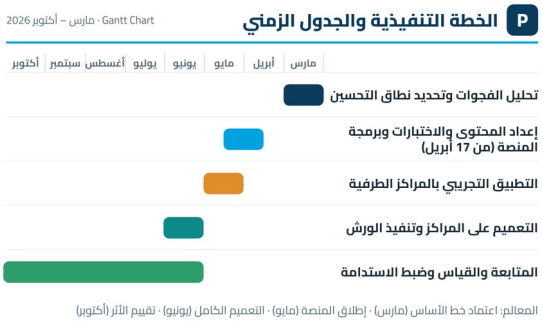
PDCA Steps / Description / Tools الخطوات / الشرح / الأدوات	Insert relevant graphs, data, charts الرسوم البيانية والبيانات والمخططات ذات الصلة

P: Plan – الخطة التنفيذية للحلول

الوصف: خطة تنفيذية تحدد لكل نشاط: ماذا، ومن، ومتى، ومؤشر النجاح، على 5 مراحل: تحليل الفجوات واعتماد خط الأساس ومقاييس النجاح في مارس، ثم إعداد المحتوى والاختبارات وبرمجة المنصة مع المطوّر التقني بدءًا من 17 أبريل، ثم التجربة على نطاق صغير بالمراكز الطرفية في مايو، ثم التعميم وتنفيذ الورش في يونيو، ثم المتابعة والقياس حتى أكتوبر. **حُدِّدت 4 مؤشرات نجاح مرتبطة مباشرة بالهدف الذكي.**

الأداة: خطة العمل ومخطط جانت (Action Plan / Gantt Chart)

P الخطة التنفيذية والجدول الزمني — Gantt Chart · مارس – أكتوبر 2026



المعالم: اعتماد خط الأساس (مارس) · إطلاق المنصة (مايو) · التعميم الكامل (يونيو) · تقييم الأثر (أكتوبر)

D: Do – تنفيذ الخطة (نطاق صغير)

الوصف: بدأ **التطبيق التجريبي في مايو 2026 بالمراكز الطرفية** (الأكثر تأثرًا بالبعد الجغرافي) للتحقق من سهولة الدخول ووضوح المحتوى وعمل الاختبارات، ثم **عُمِّم في يونيو على المراكز العشرة**. أُتيحت 5 محاضرات مسجلة تغطي 12 موضوعًا مع اختبارات إلكترونية قبلية وبعدية لكل موضوع، ونُفِّذت 10 ورش تطبيقية داخل المراكز، مع متابعة الدخول وإتمام التقييمات دون الحاجة إلى مواعيد بث مباشر متكررة.

الأداة: **قائمة التحقق من التنفيذ (Implementation Checklist) + التجربة المرحلية (Pilot)**

D مخرجات التنفيذ — Implementation Checklist

5 محاضرات مسجّلة ✔	12 موضوعًا تدريبيًا ✔	10 مراكز رعاية أولية ✔
55 ممرضًا وممرضة مستهدفين	45 مستخدمًا للمنصة ✔	10 ورش تطبيقية ✔

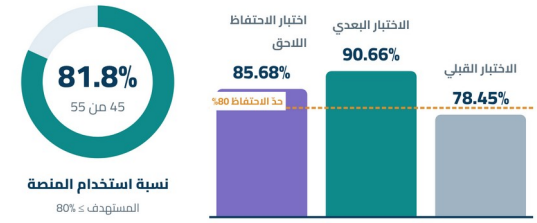
اختبارات إلكترونية قبلية وبعدية مدمجة بكل موضوع + اختبار ورقي لاحق للاحتفاظ بالمعلومات

C: Check – متابعة وتقييم التنفيذ

الوصف: قيس الأثر على مستوى «التعلّم» (المستوى الثاني في نموذج Kirkpatrick) عبر **62 سجل تقييم مقترن**: ارتفع المتوسط المرجح من **78.45%** إلى **90.66%** (+12.21 نقطة مئوية؛ تحسّن نسبي 15.6%)، وبلغ متوسط الاختبار الورقي اللاحق للاحتفاظ بالمعلومات **85.68%** (37 نتيجة). واستخدم المنصة **45 من 55 مستهدفًا (81.8%)**، وتحققت مستهدفات الخطة الأكاديمية للأرباع الثلاثة الأولى من 2026 بنسبة **100%** مقابل خط أساس 69.60%.

الأداة: **تحليل قبلي–بعدي (Pre–Post Analysis) + لوحة مؤشرات (KPI Dashboard) + مخطط التشغيل (Run Chart)**

C التحليل القبلي – البعدي — Kirkpatrick – «التعلّم» · المستوى 2 · Pre–Post



تحسّن معرفي 12.21+ نقطة مئوية (15.6% نسبيًا) · 62 سجلًا مقترنًا

A: Act – تعميم التنفيذ والاستمرارية

الوصف: يُحافَظ على التعلّم المدمج قناةً ثابتة للتدريب النظري في المراكز العشرة وفق **خطة ضبط** تحدد لكل مؤشر تكرار المتابعة وحدّ التدخل؛ وأي انحراف يُطلق دورة PDCA جديدة. وتشمل الاستدامة: تحديث المحتوى وفق الأدلة الإرشادية، وتوظيف نتائج الاختبارات لتحديد الفجوات المعرفية وتوجيه الخطة التدريبية المقبلة. **فرص التعميم:** إدراج المحتوى ضمن تهيئة الموظفين الجدد، ونقل التجربة إلى قطاعات وفئات مهنية أخرى بالتجمع.

الأداة: **خطة الضبط (Control Plan) + التوحيد القياسي (Standardization)**

A خطة الضبط والاستدامة (Control Plan)

ما يُراقَب	التكرار	حدّ التدخل
إنجاز المستهدفات الأكاديمية	ربع سنوي	أقل من 100%
نسبة استخدام المنصة	شهري	أقل من 80%
الفرق القبلي – البعدي	لكل موضوع	أقل من 10 نقاط
اختبار الاحتفاظ اللاحق	ربع سنوي	أقل من 80%
تحديث المحتوى العلمي	سنوي / عند التحديث	تغيّر الأدلة الإرشادية

الانحراف عن الحدّ يُطلق دورة PDCA جديدة لتحليل السبب وتصحيحه

Project Results (achievements) نتائج المشروع (الإنجاز)

Illustrate improvement (pre and post project) توضيح التحسن (قبل وبعد المشروع)	Insert relevant graphs, data, charts الرسوم البيانية والبيانات ذات الصلة

Data Baseline – Target – Improvement
البيانات الأساسية – المستهدف – التحسين

☐ Achieved Target (تحقيق المستهدف) فقط

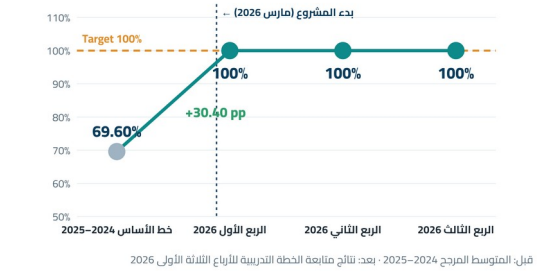
☑ **Exceeded Target (تخطي المستهدف)** – تجاوزت 3 مؤشرات من 5 مستهدفاتها وتحقق المؤشران الآخران بالكامل

☐ Not Achieved Target (لم يتحقق المستهدف)

كيف؟ بمعالجة السببين الجذريين معًا: فصل التعلّم النظري عن الموعد الثابت (مرونة تتوافق مع المناوبات)، ودمج القياس في مسار التعلّم (قبلي/بعدي/لاحق) لتوجيه المتابعة.

القيمة النسبية: ارتفاع إنجاز المستهدفات الأكاديمية بنسبة 43.7% مقارنة بخط الأساس (من 69.60% إلى 100%).

إنجاز المستهدفات الأكاديمية قبل وبعد — Run Chart



قبل: المتوسط المرجح 2024–2025 · بعد: نتائج متابعة الخطة التدريبية للأرباع الثلاثة الأولى 2026

المؤشر	خط الأساس	المستهدف	المتحقق	التحسن	الحالة / كيف تحقق؟
إنجاز المستهدفات الأكاديمية	69.60%	100%	100%	+30.40 ن.م	☑ تحقق المستهدف إتاحة التعلّم عند الطلب بما يتوافق مع المناوبات
استخدام المنصة من المستهدفين	—	≥ 80%	81.8%) (45/55	قناة جديدة	☑ تجاوز المستهدف منصة موحدة لـ10 مراكز بدل مواعيد بث ثابتة
الفرق القبلي – البعدي	غير مُقاس	≤ 10 ن.م	+12.21 ن.م	78.45% ← 90.66%	☑ تجاوز المستهدف محتوى مسجّل قابل للمراجعة + اختبارات مدمجة
اختبار الاحتفاظ اللاحق	غير مُقاس	≥ 80%	85.68%	+5.68 ن.م عن المستهدف	☑ تجاوز المستهدف تعزيز بالورش التطبيقية داخل المراكز
تغطية المحتوى التدريبي	—	12 موضوعًا / 10 مراكز	12 / 10	100%	☑ تحقق المستهدف 5 محاضرات مسجلة + 10 ورش تطبيقية

ن.م = نقطة مئوية · المقاييس: المؤشرات الأكاديمية المعتمدة، سجلات المنصة، نتائج الاختبارات الإلكترونية والورقية.

Value Benefits/Impact: What is the improvement outcome? القيمة / الفوائد / التأثير: ما هي نتيجة التحسين؟

☐ Reduced Costs (انخفاض التكاليف) – لم تُنسب وفورات مالية غير مُقاسة
☑ **Reduced Risks (تقليل المخاطر)** – عبر رفع الكفاءة المعرفية للكادر
☑ **Reduced Effort (تقليل المجهود)** – إلغاء إعادة المحاضرات والتنسيق المتكرر
☑ **Add Improvement (Process / Time) (تحسين عملية – وقت)** – مسار تعلّم مرن عند الطلب
☑ **Others (أخرى):** قياس منهجي لأثر التعلّم · قابلية التعميم

Add Comments / Illustration – تعليق أو شرح

تجسّد المبادرة مفهوم **الرعاية الصحية القائمة على القيمة (Value-Based Health Care)**؛ إذ القيمة = النتائج المتحققة ÷ تكلفة تحقيقها (Porter, 2010). فقد ارتفعت النتائج (إنجاز 100% وتحسّن معرفي +12.21 ن.م) مع خفض الجهد التشغيلي المتكرر، لأن المحتوى المسجّل يُنتَج مرة واحدة ويُعاد استخدامه دون تفريغ الكادر من المناوبات.

بُعد الجودة (دليل المسابقة)	التحسن المتحقق	الدليل / المقياس
الفاعلية (Effectiveness)	تحقيق كامل للمستهدفات الأكاديمية ورفع المعرفة التمريضية مع الاحتفاظ بها.	100% إنجاز · +12.21 ن.م · احتفاظ 85.68%
الكفاءة (Efficiency)	إنتاج المحتوى مرة واحدة وإعادة استخدامه لكل الكادر والموظفين الجدد، وإلغاء الحاجة إلى إعادة المحاضرات والتنسيق المتكرر لمواعيد البث.	من بث متكرر بمواعيد ثابتة ← 5 محاضرات مسجلة دائمة لـ 10 مراكز
محورية المستفيد (Patient / Staff Centered)	تعلّم في الوقت المناسب لكل ممرض/ممرضة دون تعارض مع المناوبات وتغطية العيادات، ودون انقطاع الخدمة للمرضى.	استخدام 81.8% (45/55) · وصول على مدار الساعة
السلامة (Safety) – غير مباشر	رفع الجاهزية المعرفية في مجالات ذات صلة بسلامة المرضى مثل العلاج الوريدي وتحليل الأسباب الجذرية.	نتائج الاختبارات حسب الموضوع (أثر سريري غير مُقاس مباشرة)

الأسس العلمية والمرجعية

1. Batalden PB, Stoltz PK. A framework for the continual improvement of health care. Jt Comm J Qual Improv. 1993;19(10):432-452.
2. Langley GJ, Moen RD, Nolan KM, et al. The Improvement Guide. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2009.
3. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: National Academies Press; 2001.
4. Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med. 2010;363(26):2477-2481.
5. Kirkpatrick DL, Kirkpatrick JD. Evaluating Training Programs: The Four Levels. 3rd ed. San Francisco: Berrett-Koehler; 2006.
6. Liu Q, Peng W, Zhang F, et al. The effectiveness of blended learning in health professions: systematic review and meta-analysis. J Med Internet Res. 2016;18(1):e2.
7. Provost LP, Murray SK. The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement. San Francisco: Jossey-Bass; 2011.

التاريخ / / 20م
الموضوع : .....
المشفوعات : .....
الرقم : .....

Project Lead Team Members قائد الفريق	Team Members أعضاء الفريق
مشرفة التدريب والتعليم التمريضي – قائدة المشروع الاسم:	1. المطوّر التقني – برمجة المنصة الإلكترونية (دور داعم) 2. .....
Hospital Manager's Name **مدير المستشفى / الجهة**	**Approval / Signature** **الاعتماد / التوقيع**
.....	.....